SECUELAS DE LA CIRUGÍA GASTRODUODENAL

DRA. DEBBIE WONG

SÍNDROME DE ASA AFERENTE

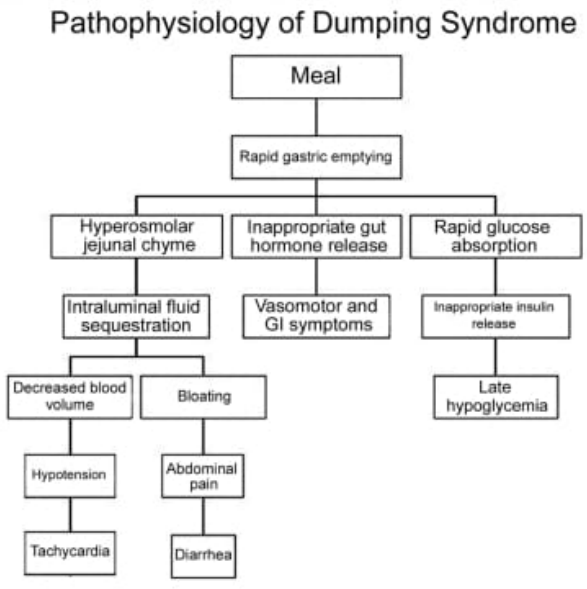
- Exclusivo de Billroth II: el asa que transporta bilis y jugo pancreático se bloquea o se dobla.
- Dolor postprandial que remite bruscamente con vómito bilioso sin alimento; se corrige convirtiendo a Y de Roux.

ÚLCERA MARGINAL O RECURRENTE

- En la anastomosis gastroyeyunal, más frecuente tras bypass gástrico o Billroth II; factores: tabaquismo, AINEs, H. pylori residual, isquemia de la línea de grapas.
- Tratamiento: IBP a dosis altas, suspender AINEs/tabaco; cirugía si hay perforación o sangrado refractario.

DUMPING PRECOZ (10–30 MIN)

- Quimo hiperosmolar al yeyuno → hipovolemia relativa.
- Náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, mareo, taquicardia y rubor.



GASTRITIS POR REFLUJO BILIAR

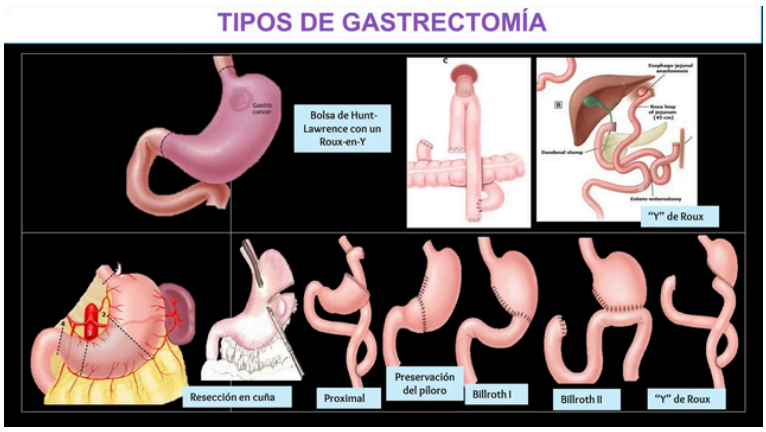
- Contacto mantenido de bilis/jugo pancreático sobre la mucosa gástrica; dolor epigástrico urente continuo que no mejora con el vómito.
- Tratamiento definitivo: reconversión quirúrgica a Y de Roux con asa alimentaria no menor a 50cm.

SÍNDROME DEL ASA CIEGA

- Sobrecrecimiento bacteriano en un asa excluida del tránsito; produce esteatorrea, deficiencia de B12 (consumida por bacterias) y exceso de ácido fólico (producido por las bacterias).
- Tratamiento: antibióticos de amplio espectro rotativos y corrección quirúrgica del asa cuando es posible.

COMPLICACIONES NUTRICIONALES

- Anemia ferropénica: la secuela más prevalente, por hipoclorhidria y exclusión del duodeno/yeyuno proximal.
- Osteomalacia/osteoporosis: malabsorción de calcio y vitamina D por asincronía biliopancreática.
- Diarrea posvagotomía: sales biliares no reabsorbidas estimulan la secreción colónica; se trata con colestiramina.

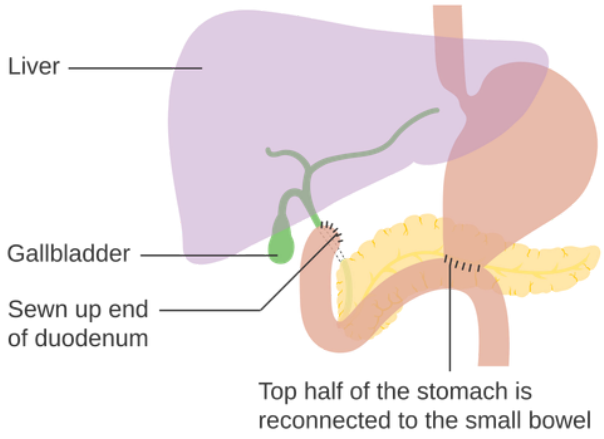


SECUELAS DE LA CIRUGÍA GASTRODUODENAL

DRA. DEBBIE WONG

TIPOS DE CIRUGÍA GASTRODUODENAL

- Gastrectomía parcial o total; vagotomía (reduce la producción de ácido); antrectomía (úlceras recurrentes); Billroth I y II (reconexión del estómago al intestino delgado); bypass gástrico.



SÍNDROME DE ASA EFERENTE

- Obstrucción mecánica en la rama de salida; oclusión intestinal alta con vómitos biliogástricos.

DUMPING TARDÍO (1–3 H)

- Absorción acelerada de glucosa → hipoglucemia reactiva: debilidad, sudoración, palpitaciones, temblor y hambre.

MANEJO DEL DUMPING

- Comidas pequeñas y frecuentes, bajas en azúcares; octreotida en refractarios; cirugía (Y de Roux) en casos extremos.

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

- Malabsorción por menor tamaño gástrico y alteración del tránsito: B12, hierro, calcio, vitamina D y folato.
- Anemia, osteoporosis, debilidad y fatiga; suplementos y monitoreo regular.

PÉRDIDA DE PESO Y MALNUTRICIÓN

- Por menor capacidad gástrica y cambios en la absorción: pérdida de peso involuntaria, debilidad y atrofia muscular; dieta balanceada, suplementos y dietista.

PROBLEMAS DE MOTILIDAD

- Alteración de nervios y músculos gástricos: gastroparesia, náuseas, vómitos y saciedad temprana; medicamentos procinéticos y cambios en la dieta.

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

- Por cambios anatómicos: ardor, regurgitación y dolor torácico; antiácidos, IBP y cambios en la dieta.

ESTENOSIS ANASTOMÓTICA

- Estrechamiento de la unión gastrointestinal: náuseas, vómitos y dificultad para comer; dilatación endoscópica o cirugía en casos severos.

CONSIDERACIONES POSTOPERATORIAS

- Seguimiento médico regular, adaptaciones dietéticas, suplementación de vitaminas y minerales, y vigilancia de síntomas nuevos o persistentes.